بسمه تعالی

پرستاری بیماریهای گوارش

اصطلاحات

Ingestion:
مرحله ای از فرایند گوارش که در طی آن غذا از طریق دهان و مری وارد لوله گوارش می شود (خوردن).

Digestion:
مرحله ای از فرایند گوارش که در طی آن آنزیمها و ترشحات گوارشی با غذای خورده شده مخلوط شده و پروتئینها و چربیها و قندها شکسته و به مولکولهای کوچکتری تجزیه می شوند.

absorption:
مرحله ای از فرایند گوارش که طی آن مولکولهای کوچک و ویتامینها و مواد معدنی از دیواره روده کوچک و بزرگ عبور کرده و وارد جریان خون می شوند.

Elimination

مرحله ای از فرایند گوارش که پس از هضم و جذب اتفاق می افتد و در طی آن محصولات زاید از بدن تخلیه می شود.

Chime

مخلوط غذا با بزاق و پتیالین(آمیلاز بزاق)که از دهان به طرف مری و معده حرکت میکند.

Fibroscopy:

وارد کردن لوله قابل ارتجاع و لامپ دار به دستگاه گوارش به منظورتشخیص و یا درمان بیماریهای خاص (آندوسکوپی وکولونوسکوپی)

آنزیم هضم نشاسته (amylase)

) آنزیم هضم چربیlipase)

آنزیم هضم پروتئین pepsin

آنزیم هضم پروتئین Trypsin

دهانMouth

مری esophagus

-معده Stomach

روده کوچک Small intestine

روده بزرگ large intestine

سیستم گوارش

لوله پیوسته ای که از دهان شروع و به مقعد ختم می شود و طول آن 700 تا 790 سانتی متر است(7 تا 7.9 متر)

1-خوردن

2-هضم

3-جذب مواد غذایی

4-دفع محصولات زاید جذب نشده

ارگانهای فرعی گوارش(کبد و کیسه صفرا وپانکراس)(کمک به فرایند هضم)از کانال گوارش محسوب نمی شوند.

مریEsophagus

مری در مدیاستن وحفره توراسیک واقع شده است

سایر قسمتهای لوله گوارش همه در حفره پریتوئن واقع شده اند

در قدام نخاع و خلف نای و قلب واقع شده است

قابلیت کلاپس شدن و اتساع دارد

25 سانتی متر طول دارد

معده stomach

- کیسه ای قابل اتساع که کیم وارد آن شده و هضم می شود

- در قسمت فوقانی شکم در طرف چپ خط مرکزی دقیقا در زیر دیافراگم چپ واقع شده است
- گنجایش آن بطور متوسط، 1500 سی سی است
- قسمت ورودی معده اسفنکتر تحتانی مری یا اسفنکتر کاردیاک نامیده می شود و در موقع انقباض ارتباط مری و معده را قطع می کند
- معده 4 قسمت کاردیا و فوندوس و تنه و پیلور است
- قسمت انتهایی معده اسفنکتر پیلور است و ارتباط معده و روده را کنترل می کند

روده کوچک

- **طویل ترین قسمت لوله گوارش است**
- **2/3 کل لوله است**
- **روی هم پیچ وخم خورده و 7000 سانتیمتر سطح برای ترشح وجذب دارد**
- **3 قسمت دئودنوم (ابتدایی) و ژژنوم (میانی) و ایلئوم(انتهایی) است**
- **CBD(common biliary duct)که ترشحات کیسه صفرا و پانکراس را دارد در محل آمپول واتر به دئودنوم باز میشود**
- **سکوم محل اتصال روده کوچک و بزرگ در قسمت راست تحتانی شکم است(ileu secal)**
- **دریچه ایلئوسکال ورود محتویات روده کوچک به بزرگ را کنترل و ازریفلاکس باکتریهای کولون به عقب جلوگیری می کند.**

colon روده بزرگ

قسمت کولون بالا رونده در راست و عرضی از راست به چپ و نزولی درطرف چپ شکم 3

قسمت انتهایی شامل کولون سیگموئید و رکتوم تا مقعد است

مقعد توسط شبکه ای از عضلات مخطط کنترل می شود

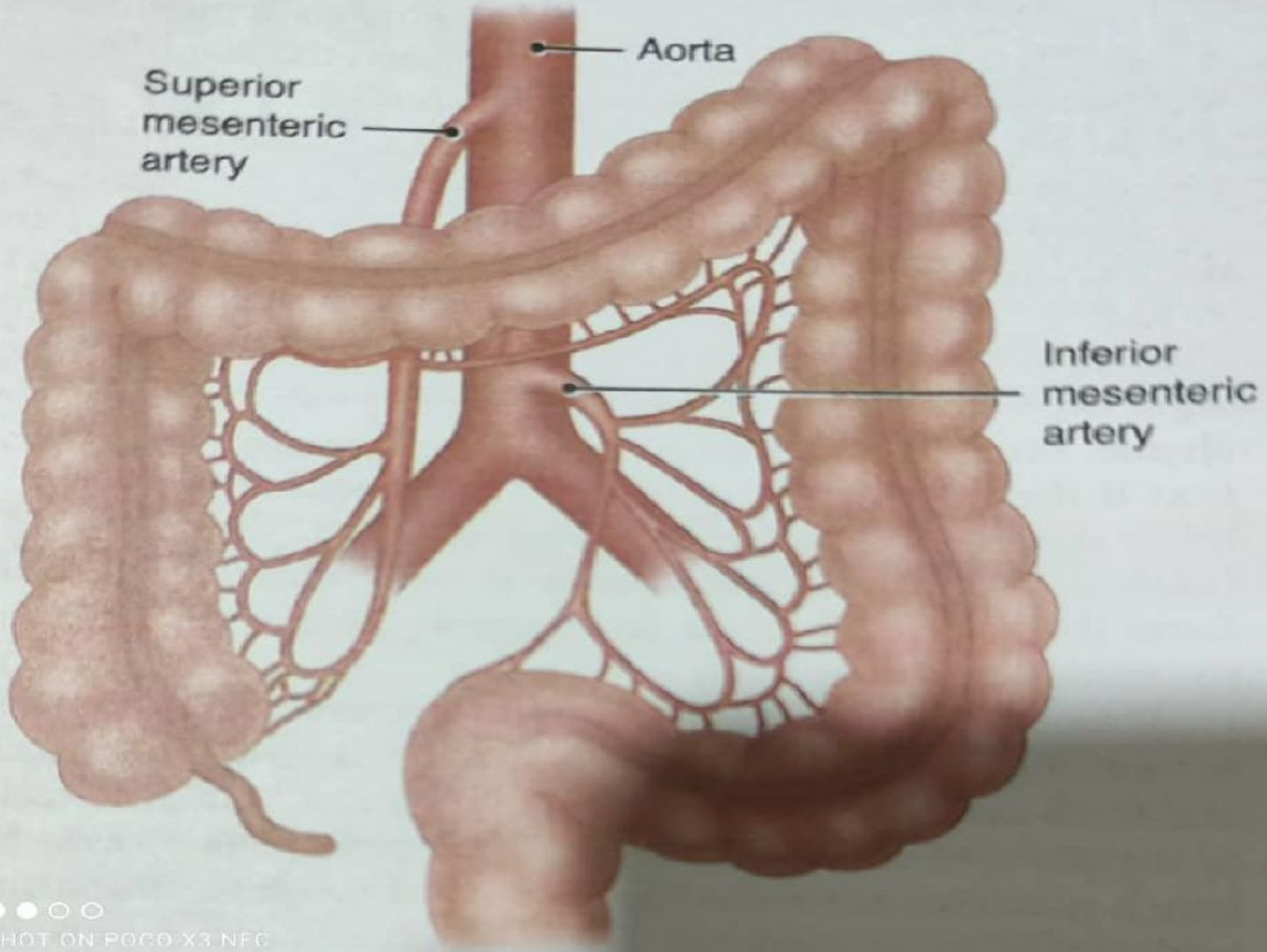
اسفنکتر خارجی مقعد و قسمت ابتدایی مری (بلع) تحت کنترل ارادی هستند بقیه قسمتها کنترل ارادی ندارند.

گردش خون دستگاه گوارش

شریانهای گاستریک و مزانتریک فوقانی و مزانتریک تحتانی که از آئورت سینه ای و شکمی منشا گرفته اند خونرسانی معده و روده را تامین می کنند

خون وریدی این ارگانها همراه با سایر وریدهای شکم جمع شده و ورید بزرگ باب یا پورت را تشکیل می دهند که غنی از مواد غذایی است و وارد کبد می شود

.لوله گوارش 20 درصد برون ده قلبی را به خود اختصاص میدهد که بعد از خوردن غذا زیاد هم میشود



SHOT ON POCO X3 NFC

عصب دهی لوله گوارش

اعصاب سمپاتیک:

اثر مهاری روی لوله گوارش دارند (کاهش ترشحات معده-کاهش حرکات دودی -انقباض عروق خونی و اسفنکترها)

اعصاب پاراسمپاتیک:

اثر تحریکی روی گوارش دارند(افزایش ترشحات-افزایش پریستالتیسم-ریلاکس شدن اسفنکترها)

قسمت فوقانی مری و اسفنکتر خارجی مقعد تحت کنترل اعصاب خودکار نیستند و ارادی هستند.

عملکرد معده

1 -ذخیره غذای بلع شده

2 -ترشح اسید کلریدریک(ترشح 2/4 لیتر اسید با 1 PHتا 3 در 24 ساعت) و آنزیم پپسین

3 - مخلوط کردن مواد غذایی با اسید و آنزیم

4 -تجزیه غذا به شکل قابل جذب

5 -از بین بردن باکتریهای بلع شده

6 -ترشح فاکتور داخلی از مخاط معده(ترکیب با ویتامین B 12 وجذب در ایلئوم)

(ویتامین B12 از مواد ضروری برای ساخت گلبول قرمز است)

7 -وارد کردن محتویات خرد شده به دوازدهه با حرکات دودی

غذا در معده از 1 تا چند ساعت ممکن است بماند.

عملکرد روده

1- امولیسیفیکاسیون چربیها با ریزش صفرا روی کیموس

2- خنثی کردن اسید معده با ریزش بیکربنات ترشح شده از پانکراس

3- ترشح آمیلاز و لیپاز و تریپسین از پانکراس برای هضم مواد

4- ترشح موکوس از غدد روده ای برای محافظت مخاط روده، در برابر اسید معده و بیکربنات پانکراس

5- ایجاد امواج مختلط و خرد کننده برای هضم غذا

6- ایجاد پریستالتیس برای حرکت رو به جلو محتویات داخل روده

7- جذب کربوهیدراتهای تبدیل شده به گلوکز و فروکتوز ،پروتئین تبدیل شده به آمینواسید و تری گلیسریدهای تبدیل شده به اسیدچرب

کل ترشحات روده ای در طول 24 ساعت-:

یک لیتر شیره پانکراس-

نیم لیتر صفرا-

سه لیتر ترشحات خود روده

ویتامین ها ومواد معدنی بدون هضم وتغییر به طریق انتقال فعال و انتشار در-

ژژنوم جذب می شوند

ساعت بعد از صرف غذا مواد زاید باقیمانده وارد ایلئوم انتهایی شده وازطریق دریچه 4 ایلئوسکال وارد کولون میشود

عملکرد کولون

باکتریها یکی از اجزای اصلی روده بزرگ هستند

1-تجزیه مواد هضم نشده توسط باکتریها

2-جذب آب والکترولیتها

3-انتقال محتویات مانده به رکتوم با حرکات دودی آهسته

قسمت اعظم مدفوع از ترشحات گوارش است و منشا غیر غذایی دارد

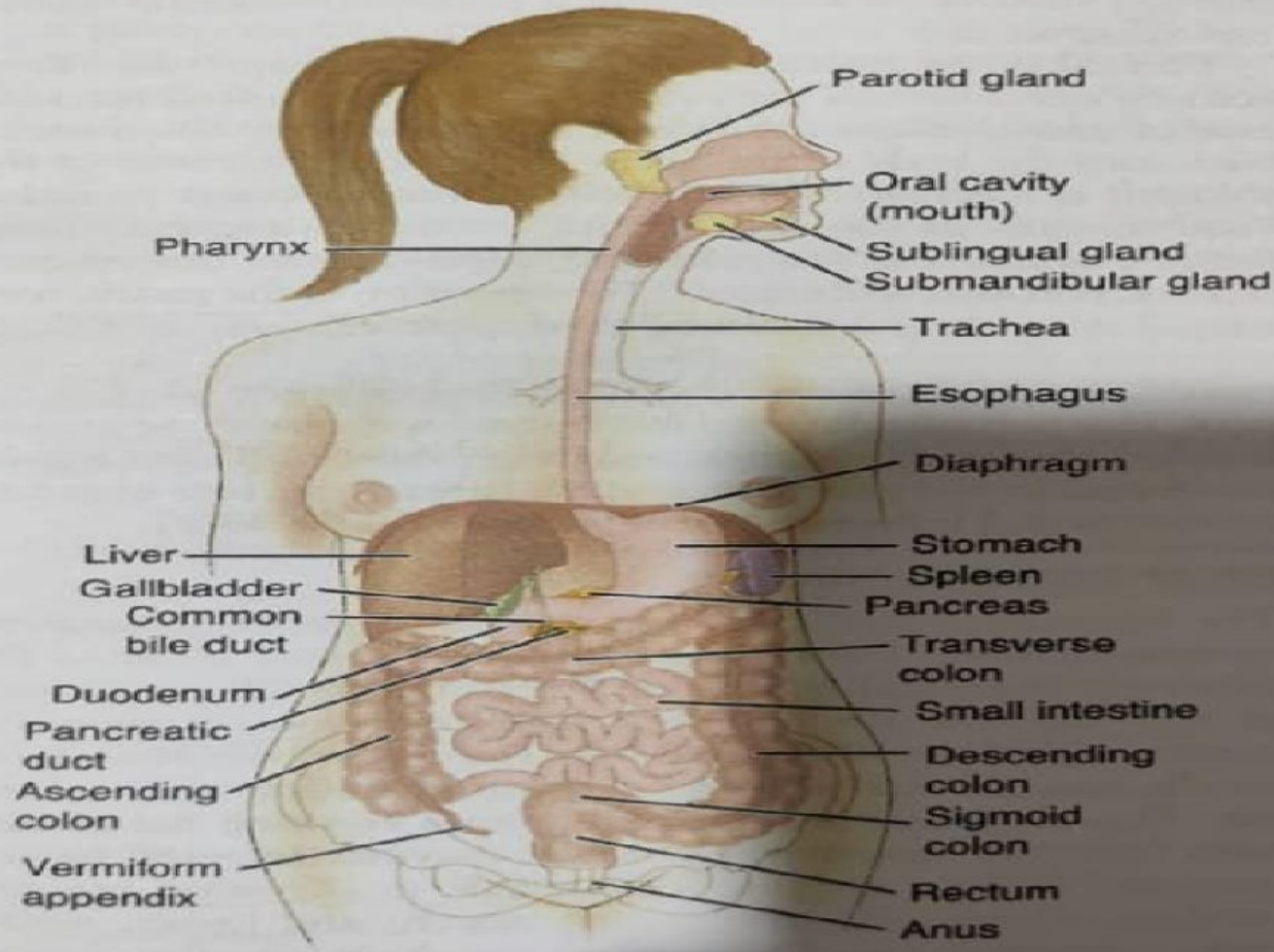
رنگ قهوه ای مدفوع ناشی از تجزیه صفرا توسط باکتریها است

گازهایی مثل متان وسولفید هیدروژن وآمونیاک(150 میلی لیتر) حاصل فعالیت باکتریهای روده است

.این گازها یا از رکتوم دفع میشوند ولی قسمت اعظم آن از طریق ورید باب واردکبد شده و سم زدایی می شود

Anatomic and Physiologic Overview

The GI tract is a pathway 7 to 7.9 m (23 to 26 feet) in length that extends from the mouth to the esophagus, stomach, small and large intestines, and rectum, to the terminal structure, the **anus** (Fig. 38-1). The **esophagus** is located in the mediastinum, anterior to the spine and posterior to the trachea



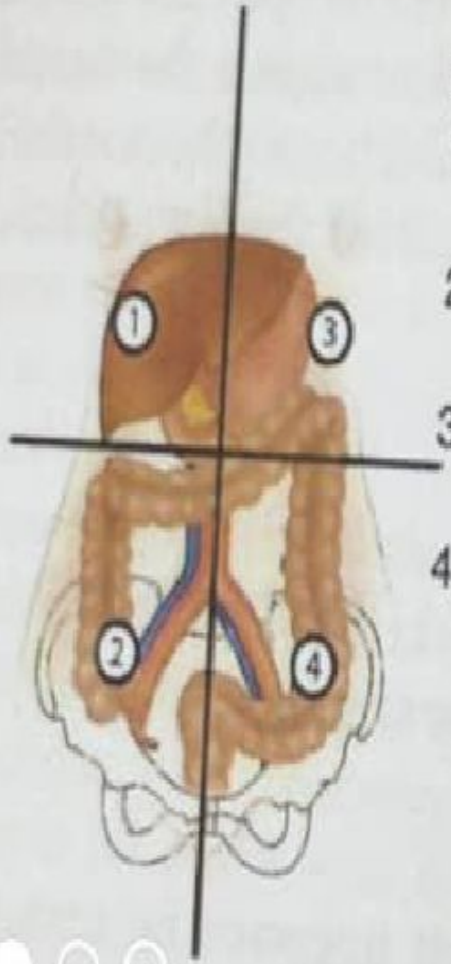
جدول ۲-۱: مواد اصلی تنظیم کننده گوارشی

ماده	تحریک برای تولید	بافت هدف	تاثیر بر ترشحات گوارشی	تاثیر بر حرکات گوارشی
تنظیم عصبی				
استیل کولین	بینایی، بویایی، جویدن غذا، اتساع معده	غدد معدی، سایر غدد ترشحی، عضلات گوارشی	افزایش اسید معده	افزایش عمومی - کاهش تون اسفنکتر
نورایی نفرین	استرس، سایر محرکها	غدد ترشحی، عضلات گوارشی	مهار عمومی	کاهش عمومی - افزایش تون اسفنکتر
تنظیم هورمونی				
گاسترین	اتساع معده بوسیله غذا	غدد معدی	افزایش ترشح شیره معدی که سرشار از HCL است.	افزایش حرکات معده - کاهش زمان لازم برای تخلیه معده - شل کردن اسفنکتر ایلئوسکال - تحریک کولون - انقباض اسفنکتر مری - معدی-
کوله‌سیستوکینین	چربی در دئودنوم	- کیسه صفرا - پانکراس - معده	- آزاد شدن صفرا در دئودنوم - افزایش تولید شیره پانکراس سرشار از آنزیم - مهار کل ترشحات معدی	مهار انقباضات معدی
سکرتین	PH کیم درد دئودنوم پایین‌تر از ۴-۵	- معده - پانکراس	- مهار کل ترشحات معدی - افزایش تولید شیره پانکراس سرشار از بیکربنات	
تنظیم موضعی				
هیستامین	نامشخص، مواد در غذا	غدد معدی	افزایش تولید اسید معده	

SHOT ON POCO X3 NFC

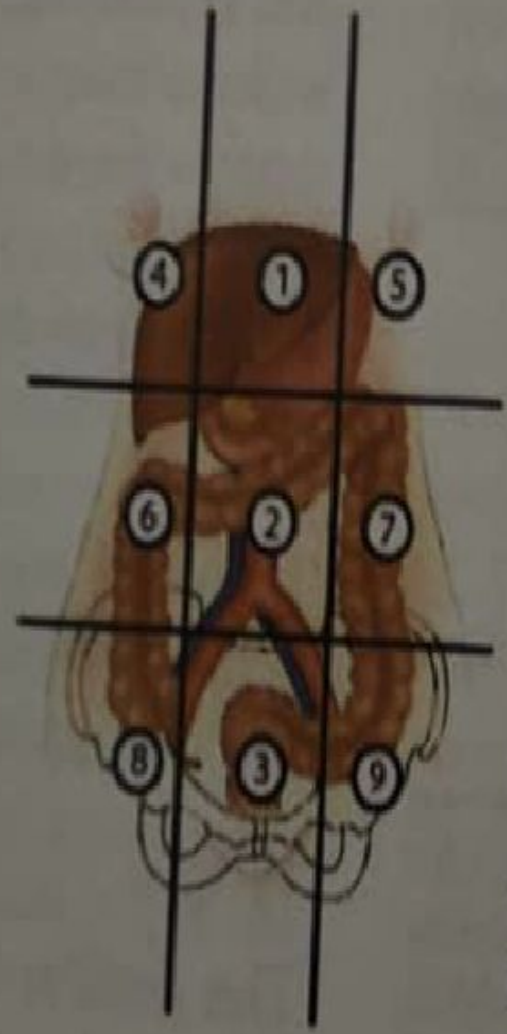
بررسی تظاهرات بالینی

- **درد**
- **ویژگی درد**
- **طول مدت درد**
- **تکرر درد**
- **محل درد**
- **انتشار**
- **زمان درد**
- **ارتباط درد با غذا خوردن**
- **ارتباط درد با دفع مدفوع**



Four quadrants

1 - right upper quadrant (RUQ)
2 - right lower quadrant (RLQ)
3 - left upper quadrant (LUQ)
4 - left lower quadrant (LLQ)



Nine regions

1 - epigastric region
2 - umbilical region
3 - hypogastric or suprapubic region
4 - right hypochondriac region
5 - left hypochondriac region
6 - right lumbar region
7 - left lumbar region
8 - right inguinal region
9 - left inguinal region

SHOT ON POCO X3 NFC

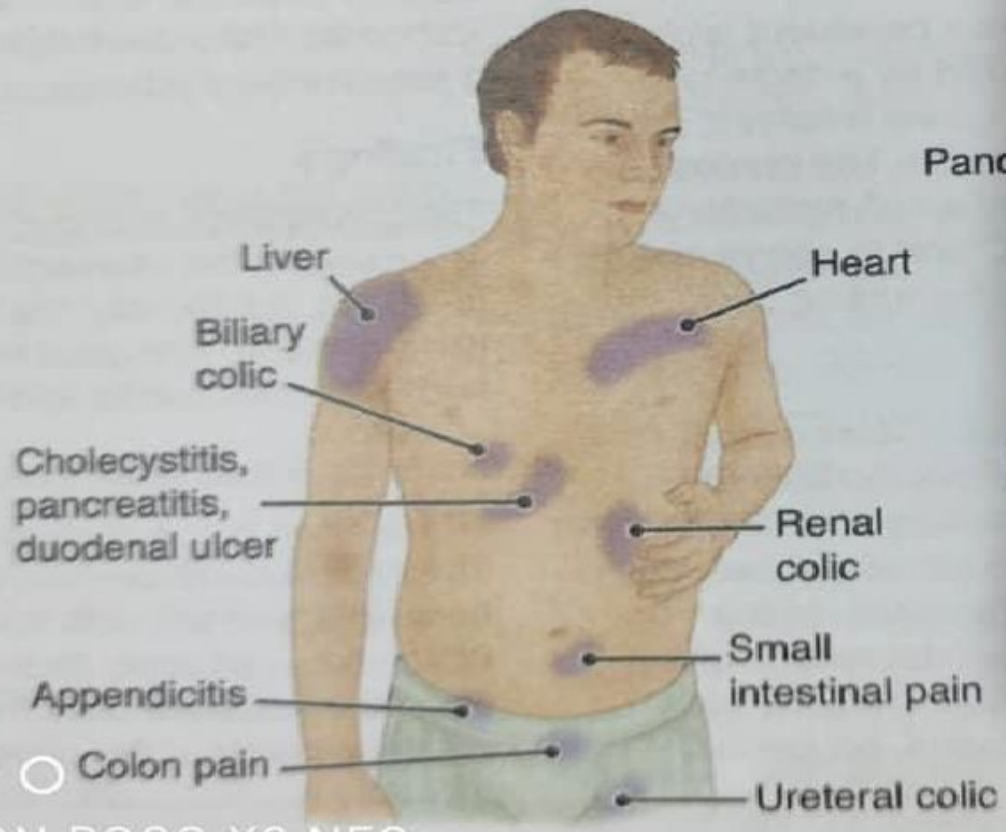
often produce skin

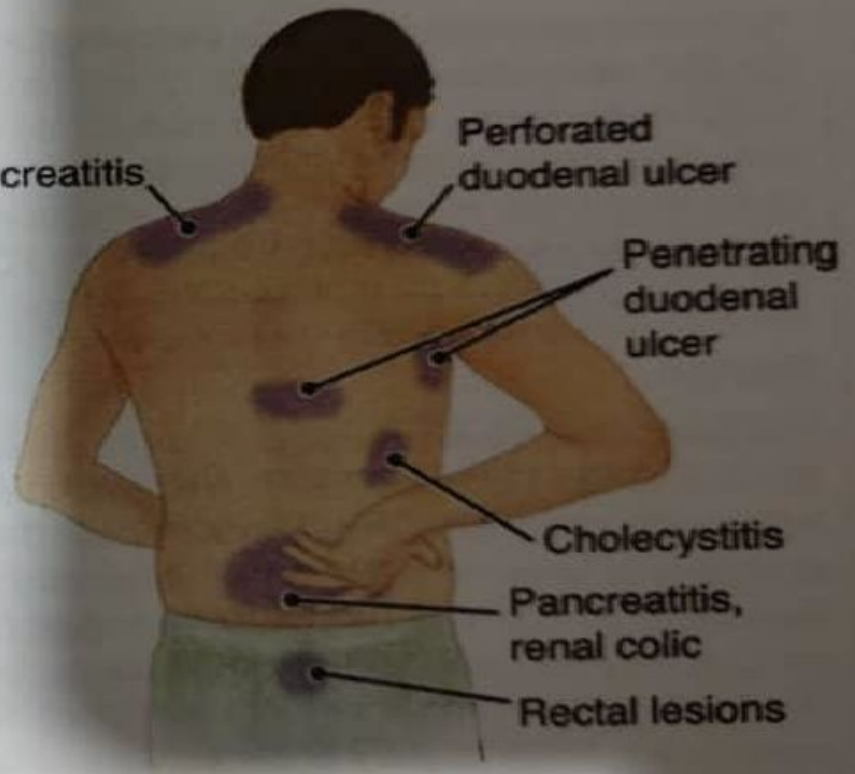
cid.
18). Gerontological nursing (9th ed.). Philadelphia,

t begins with a complete history. Infor-
l pain, dyspepsia, gas, nausea and vom-
tion, fecal incontinence, jaundice, and
btained (Weber & Kelley, 2018).

Intestinal Gas

The accumulation of gas in the GI tract may result in belching (expulsion of gas from the stomach through the mouth) or flatulence (expulsion of gas from the rectum). Usually, gases in the small intestine pass into the colon and are released as flatus. Patients often complain of bloating, distention, or feeling "full of gas" with excessive flatulence as a symptom of food intolerance or gallbladder disease.





non sites of

SHOT ON POCO X3 NFC

dyspepsia سوء هاضمه

- ناراحتی و احساس فشار در قسمت فوقانی شکم در اثرخوردن غذا
- شایعترین شکایت بیماران با اختلال عملکرد گوارشی است
- ممکن است علت عصبی و یا علت ساختاری داشته باشد
- معمولا غذاهای چرب که بیشتر در معده می مانند و سبزیجات و ادویه جات باعث ناراحتی بیشتری می شوند.

نفخ یا گاز روده

بیمار از پری گاز در معده و باد کردن واحساس نفخ شکم شکایت می کند

این گاز در معده با آروغ (belching) و در روده با دفع گاز ازمقعد(flatulence) دفع می شود.

تهوع nauisiaواستفراغvomiting

یکی از نشانه های اصلی بیماری گوارشی است

محتویات استفراغ و مواد موجود در استفراغ بررسی شود

رنگ قرمز روشن نشان از خونریزی جدید و فعال است(هماتمز)hematemesis

رنگ قهوه ای تیره نشان از خونریزی کهنه وکنترل شده است
(کافی گراند)coffee grand

تغییر در اجابت مزاج وخصوصیات مدفوع

افزایش دفعات و یا کاهش دفعات اجابت مزاج و یا هر گونه تغییر در اجابت مزاج بررسی می شود

رنگ مدفوع، زرد روشن تا قهوه ای تیره است

مدفوع دارای خون قرمز (هماتوشزیا یا رکتوراژی) نشان ازخونریزی فعال در قسمت تحتانی گوارش است

مدفوع قیری رنگ(ملناmelna) نشان از خونریزی قسمت فوقانی گوارش است.